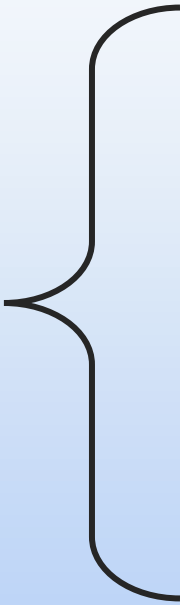


Dermatoze buloase autoimune



Agenda



Pemfigus vulgar
Pemfigoid bulos

Dermatozele buloase autoimune

- Leziuni veziculo-buloase cutanate și/sau mucoase, localizare intraepidermică sau subepidermică
- autoanticorpi orientați împotriva unor structuri cutanate de adeziune interkeratinocitare sau din membrana bazală

➤ Grupul pemfigus

- **Pemfigus vulgar** cu varianta pemfigus vegetant
- Pemfigus foliaceu cu varianta pemfigus eritematos
- Pemfigus paraneoplazic
- Pemfigus indus medicamentos

➤ Grupul dermatozelor buloase autoimune subepidermice

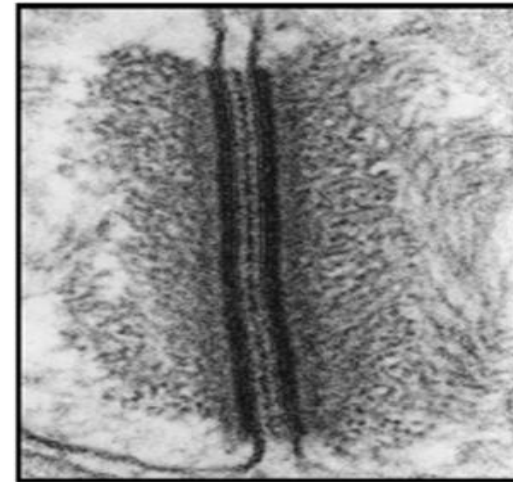
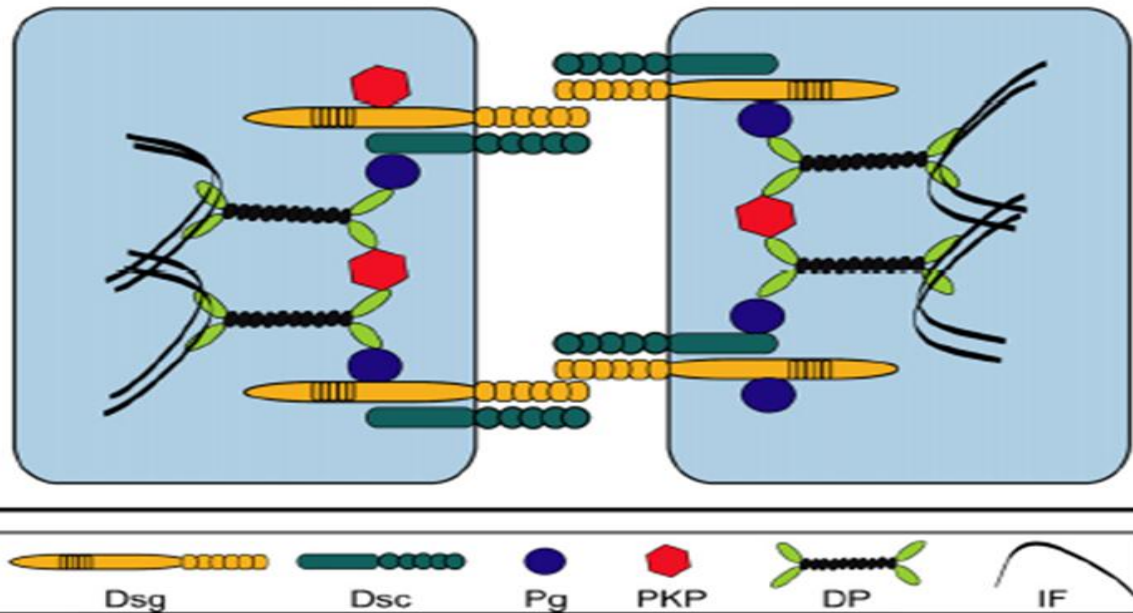
- Pemfigoid bulos

- Dermatita cu IgA liniară
- Dermatita herpetiformă



Grupul Pemfigus

- Clinic: vezicule, bule, eroziuni (mucoase)
- Histopatologic: acantoliza, vezicule **intraepidermice**
- Immunologic: autoanticorpi antidesmogleine (desmozom)



Mecanism patogenetic complex

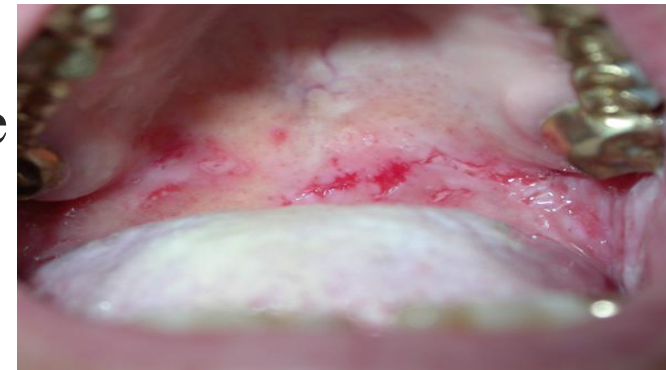
Pemfigus vulgaris

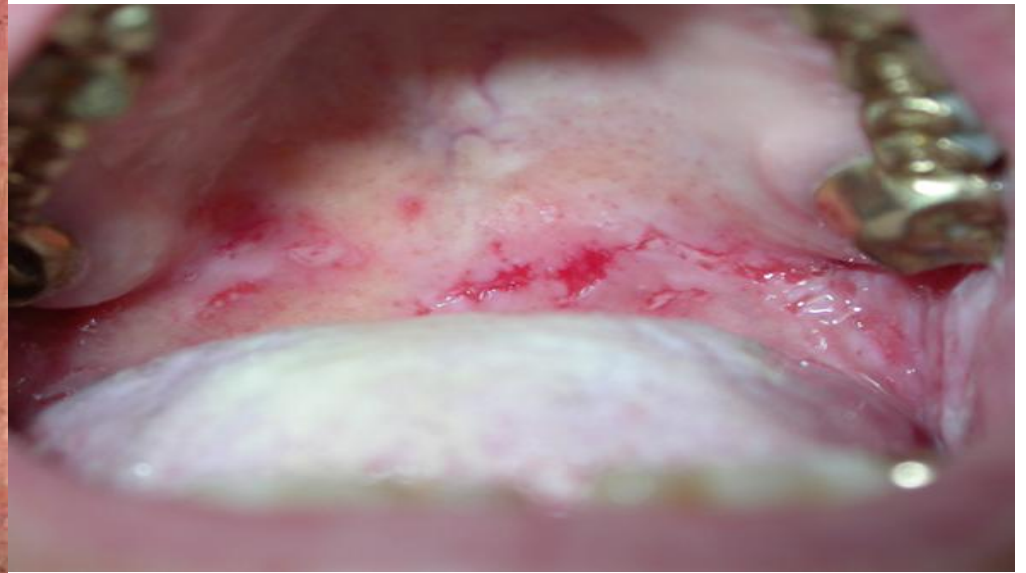
- persoanele cu susceptibilitate genetică sunt expuse unui factor declanșator din mediu;
- activarea celulelor autoreactive T și B cu producerea unei clase de **autoanticorpi**;
- legarea autoanticorpilor specifici de desmogleine;
- declanșarea mecanismelor de semnalizare celulară și apoptoză cu apariția acantolizei și formarea bulelor



Pemfigus vulgar: Clinic

- bule flasce diseminate pe piele (tegument indemn) și eroziuni la nivelul mucoaselor
- **debutează în cavitatea bucală (50%)**
- Bule intacte sunt rar observate la acest nivel întrucât sunt fragile și se sparg ușor
- eroziuni dureroase, extindere spre laringe și faringe cu disfagie secundară
- Uneori pot apar și aspecte de gingivită erozivă
- Alte mucoase ce pot fi interesate: mucoasa conjunctivală, genitală și anală

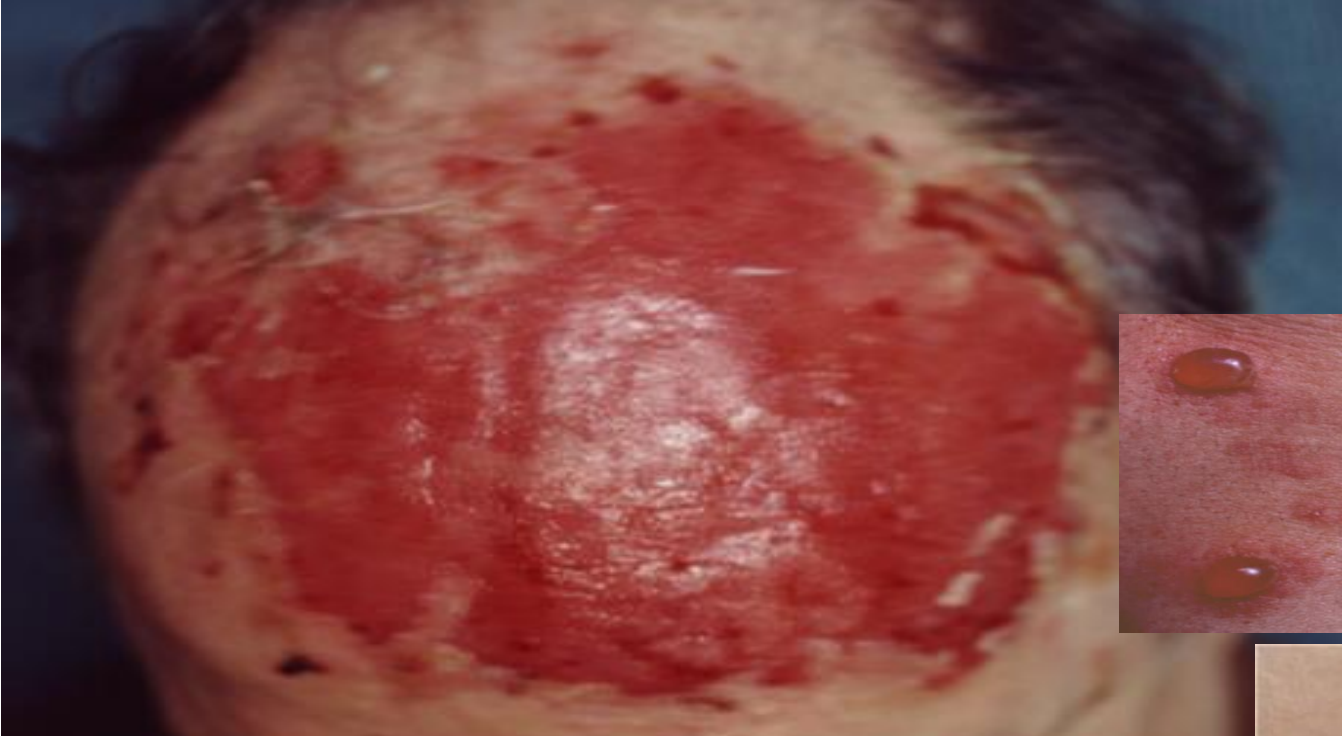




Pemfigus vulgar

- **Cutanat:** spargerea bulelor → eroziuni ce au tendința de a se extinde în periferie → cruste fara tendinta de vindecare spontana
- Fragilitatea cutanată poate fi demonstrată prin apăsarea unei bule cu degetul, rezultând o extindere periferică a leziunii
- o fricțiune realizată în vecinătatea unei bule pe tegument indemn determină decolarea epidermului (semnul Nikolsky)
- senzația de arsură și durere la nivelul zonelor denudate
- Vârsta medie de debut a bolii este între 40 – 60 de ani







Macule hiperpigmentate rezidual

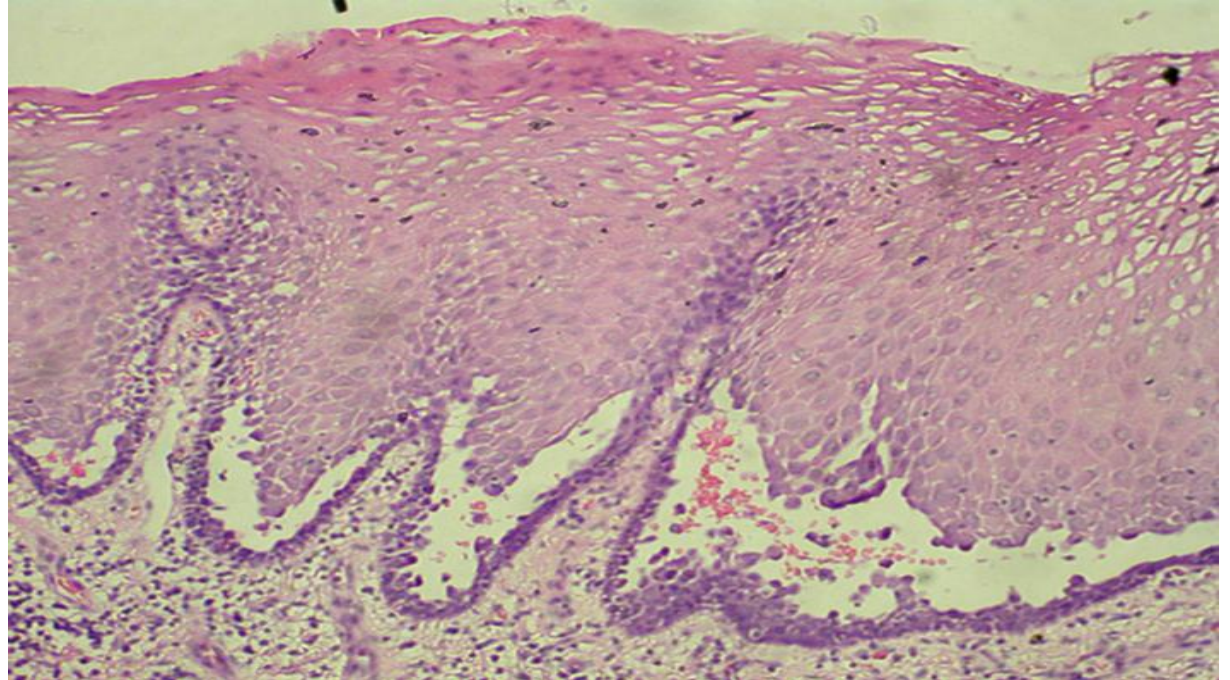
Diagnostic pemfigus

Ex histopatologic

(Leziune)

- Bula suprabazala
- Celule acantolitice
- Infiltrat inflamator

dermic



Diagnostic pemfigus

1. Imunfluorescenta **directa**

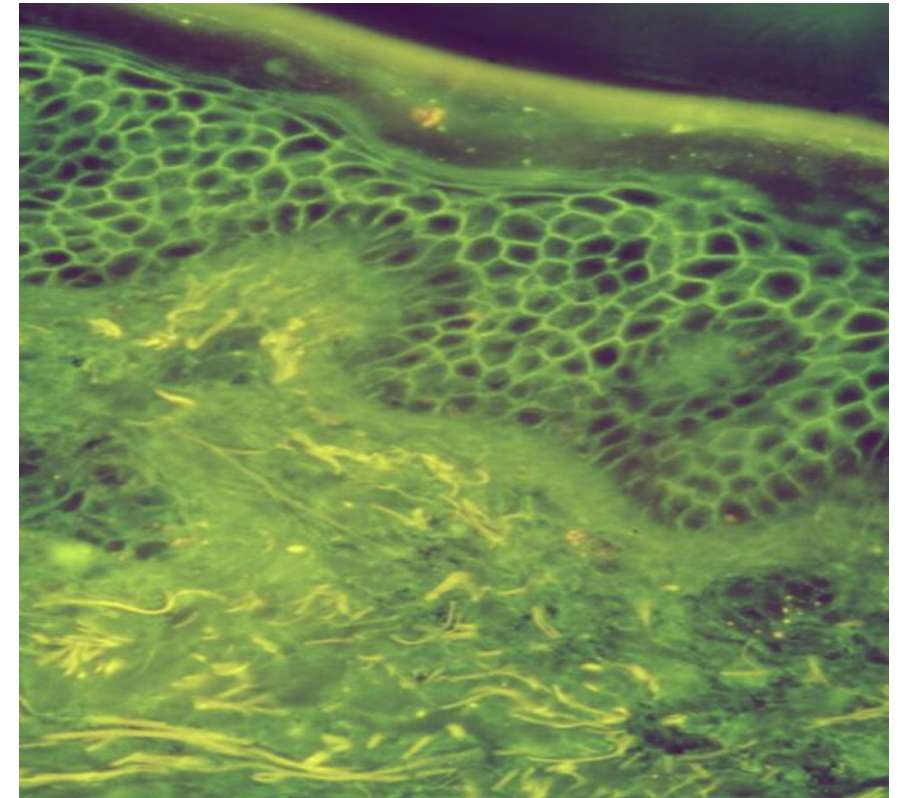
(perilezional)

- Depozite in retea

de IgG, IgM, IgA sau C3

(Definitorie pt dg cert)

2. Imunfluorescenta **indirecta**



Diagnostic pemfigus

- Imunoserologic

ELISA Nivelul de anticorpi **anti Dsg 1+/-Dsg 3**

Corelatie pozitiva intre evolutie favorabila la terapie si scaderea nivelului de anticorpi

Tehnici de dg mai putin utilizate

- Citodiagnostic Tzanck
- Imunofluorescenta indirecta (esofag de maimuta)
- Immunoblot/westernblot

Evolutie prognostic

- imprevizibilă, fără tendință la vindecare spontană a leziunilor
- Înainte de utilizarea corticosteroizilor pacienții decedau în 1-3 ani. Odată cu instituirea corticoterapiei și a imunosupresoarelor, prognosticul s-a îmbunătățit simțitor
- pemfigusul rămâne o boală cu mortalitate semnificativă (aproximativ 10% din pacienții urmăriți timp de 10 ani)
- Cauzele majore de deces sunt suprainfecția leziunilor, tulburările hidroelectrolitice și complicațiile produse de terapie.

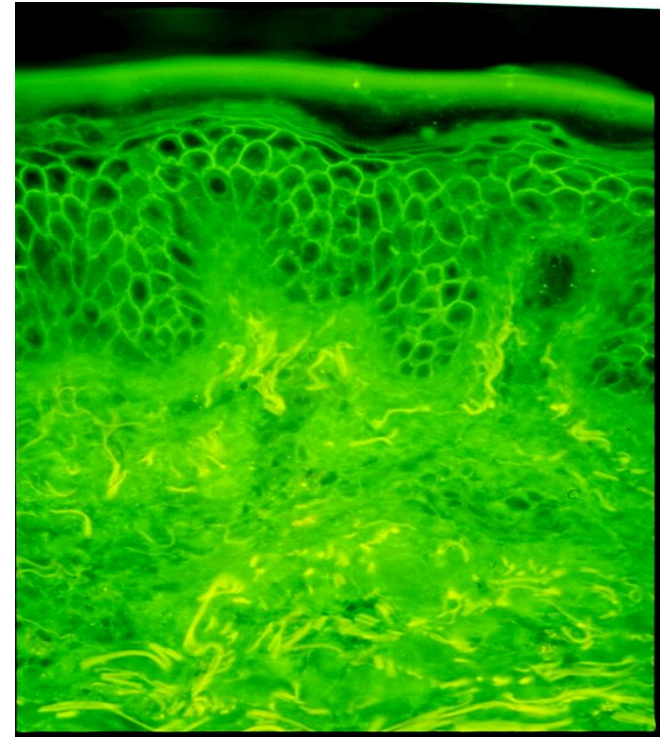
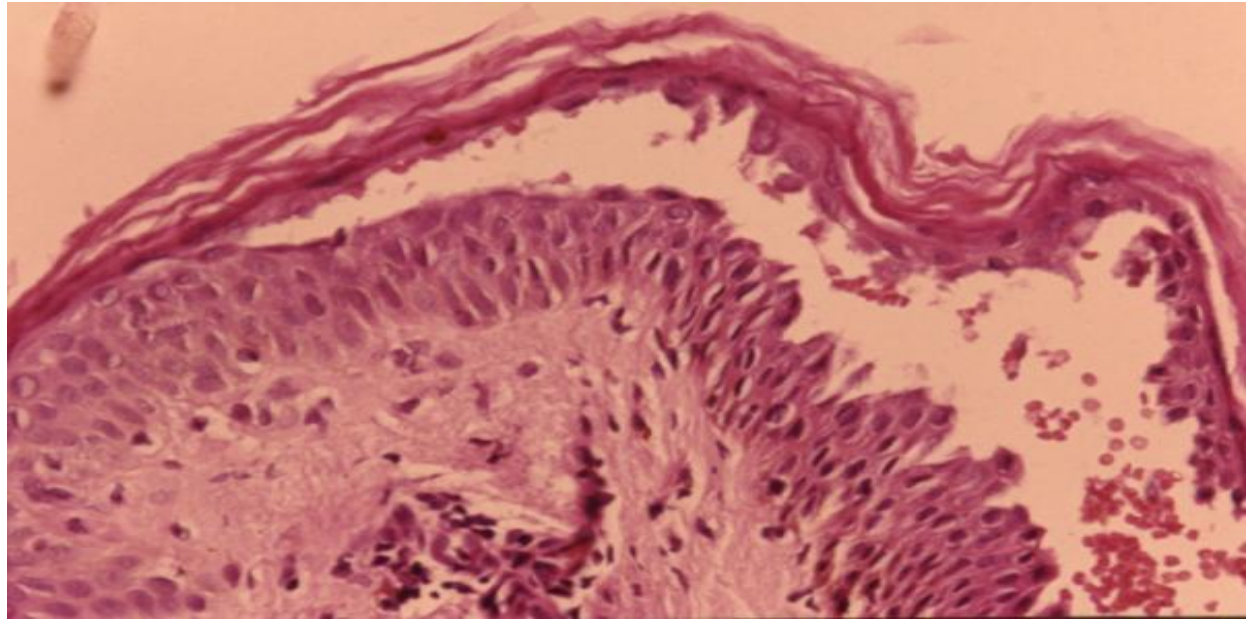
complicatii

- Legate de boala: suprainfectii, scadere in greutate, anemie, tulburari hidroelectrolitice
- Legate de tratament: corticoterapie prelungita (HTA, DZ, osteoporoza, crestere in greutate, infectii-TBC, gastrite, dis-electrolitemii, miopatie, depresie, sepsis, etc)
- Afectiune cronica, cortico-dependenta, cortico-rezistenta

Forme mai rare

- Pemfigus vegetant





Pemfigus foliaceu (superficial)

Tratament pemfigus

- **Corticoterapie sistemică** (Prednison 1mg/kgc/zi) 4-12 săptămâni apoi scădere treptată
 - asociat cu:
- Azatioprina 1-2 mg/kg/zi,
- Ciclofosfamida 50-200 mg/zi
- Micofenolat mofetil 2-2,5 g/zi
- Metotrexat 10-17,5 mg/săptămână
- Dapsona în doze de 100-150 mg/zi
- Protecție gastrică, Ca, vit D, antiagregante, K, Mg

Cazuri refractare

- **Rituximab (anti-CD20)**
- Pulsterapie cu Metilprednisolon sau Ciclofosfamida
- Micofenolat mofetil 3-6 g/zi
- Imunglobuline iv
- Plasmafereza

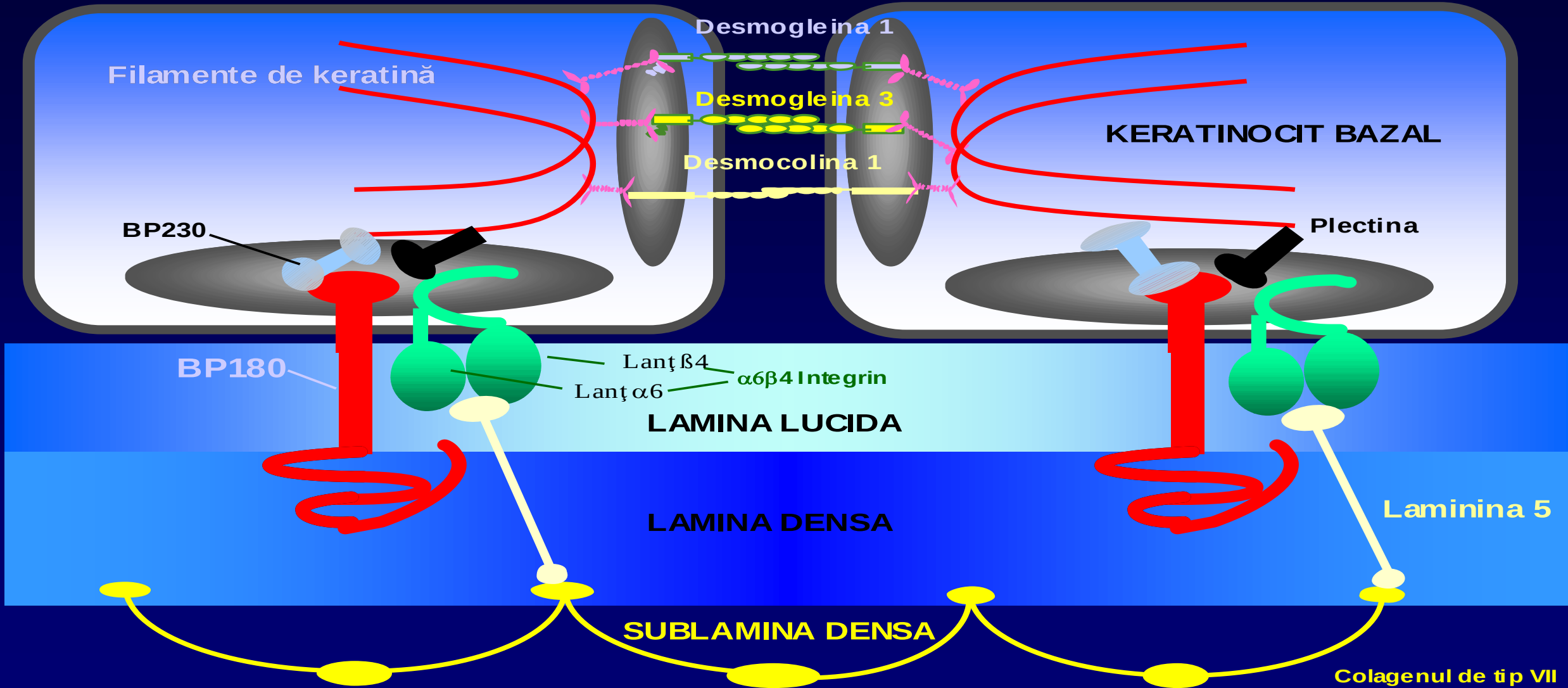
Tratament local

- Dermocorticoizi (geluri): lez mucoase
- Dermocorticoizi (+/- antibiotice topice)
- Solutii antiseptice (non-alcoolice pentru mucoase!)
- Antibiotice topice (suprainfectii)

Pemfigoidul bulos

- afecțiune autoimună
- frecvent vârstnici, rar copii
- vezicule și bule sub tensiune
- Histologic: localizarea subepidermică a bulei
- Imunologic: autoanticorpi împotriva unor componente ale joncțiunii dermo-epidermice

Desmosomul și hemidesmosomul



Mecanism patogenetic: Pemfigoid bulos

- autoanticorpi împotriva a două structuri ale hemidesmozomilor cu greutate moleculară de 180 kDa (**BP180**) și 230 kDa (**BP230**)
- autoanticorpii anti-BP180 de la pacienți cu PB recrutează leucocite la nivelul joncțiunii dermo-epidermice și induc **separarea epidermului de derm**
- formarea bulelor subepidermice depinde de activarea complementului, degranularea mastocitelor și infiltrarea cu neutrofile și/sau eozinofile

Pemfigoid bulos: aspecte clinice

- bule mari sub tensiune care apar pe pielea eritematoasă sau normală, uneori bulele se dispun la periferia zonei eritematoase
- zonele flexurale și partea inferioară a trunchiului
- eroziuni care se pot acoperi de cruste
- leziunile se vindecă frecvent cu hiperpigmentație postinflamatorie, dar **fără** cicatrici
- interesarea mucoaselor este rară
- pot fi precedate de erupții urticariene excoriate și un prurit sever





Forme clinice particulare

- *Pemfigoidul nodular* prezintă un aspect asemănător cu prurigo nodular, localizat mai frecvent pe scalp, spate și extremități
- *Pemfigoidul cicatricial* caracterizat prin leziuni erozive, dureroase, la nivelul mucoaselor care evoluează cu cicatrici care afectează funcționalitatea organului lezat
- *Pemfigoid gestationis* apare de obicei în trimestrul 2 și 3 de sarcină



Diagnostic PB

Bioumoral: eozinofilie și valori serice crescute ale IgE

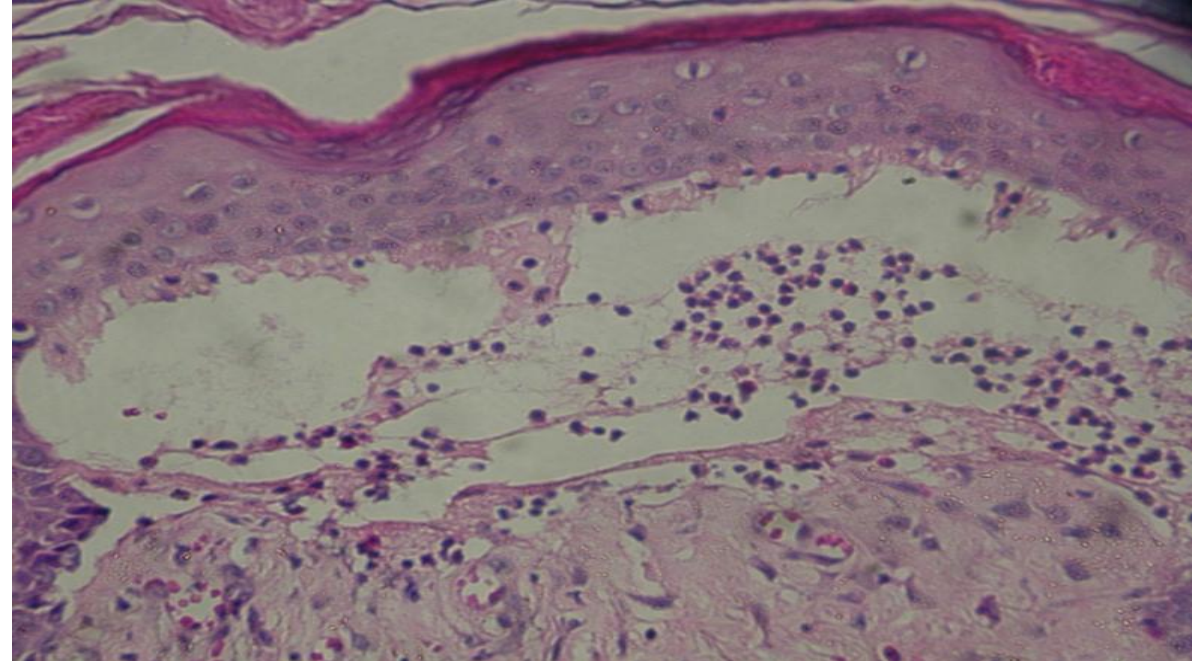
Examenul histopatologic:

bula la nivelul joncțiunii dermo-epidermice.

infiltrarea cu eozinofile

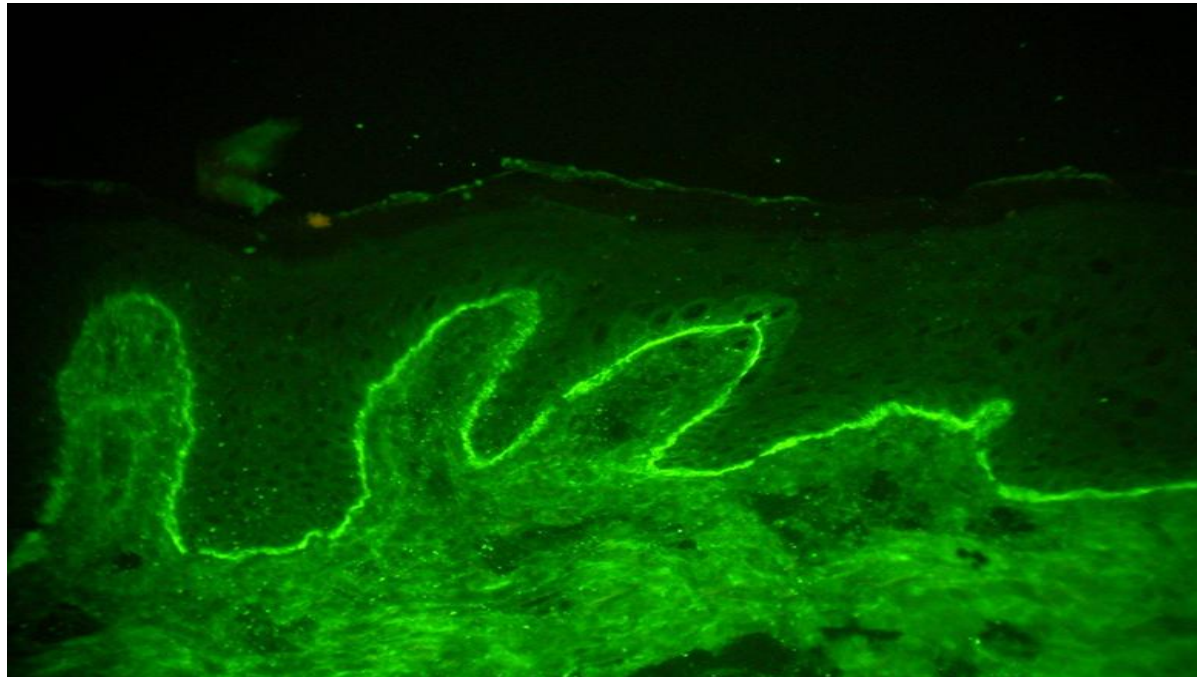
a dermului papilar și

a lichidului bulei



Imunfluorescența directă

- **Imunfluorescența directă** realizată pe pielea aparent normală, perilezională, arată depozite liniare de IgG și/sau C3 de-a lungul membranei bazale



- **Imunfluorescența indirectă** pe piele umană clivată (după incubarea pielii umane în soluție de NaCl 1 M epidermul se separă de derm la nivelul laminei lucida) evidențiază depunerea IgG pe versantul epidermic
- ELISA poate fi utilă în monitorizarea tratamentului și evoluției bolii

- **Dg diferential PV&PB:**

- alte afectiuni cu leziuni veziculo-buloase si afectare mucoasa

- Pemfigoidul bulos evoluează cu remisiuni și recidive spontane, fiind auto-limitată de obicei la 5 ani
- Prognosticul este mult mai bun decât în cazul pemfigusului, dar este grevat de apariția bolii la vârste înaintate

Tratament Pemfigoid Bulos

- Severitatea +extinderea leziunilor
- Întrucât majoritatea pacienților sunt vârstnici se vor administra dozele minime eficiente pe o durată cât mai scurtă
- Formele localizate pot fi tratate cu corticosteroizi topici cu potență mare.(10-30 g de clobetasol propionat)

Tratament Pemfigoid Bulos

- pemfigoid bulos generalizat: **Prednison 0,5-1 mg/kg/zi** pentru 2-3 săptămâni (epitelizare)
- Scadere progresiva, lunga durata (evitarea recidivelor)
- !!!!Efectele adverse ale corticoterapiei sistemice (osteoporoză, diabet, imunosupresia, etc) pot fi grave la vârstnici!!!
- monitorizarea terapiei este foarte importantă, complicațiile date de tratament pot fi mai severe decât complicațiile bolii

Tratament Pemfigoid Bulos

Asocieri sau alternative la corticoterapie:

- Azatioprina
- Ciclofosfamida
- Metotrexat
- Micofenolat mofetil
- Sulfonele (dapsona, sulfapiridina)
- asocierea tetraciclină și nicotinamidă
- Plasmafereza
- Imunglobulinele intravenos
- rituximab

Multumesc

Elisabeta.candrea@umfcluj.ro

